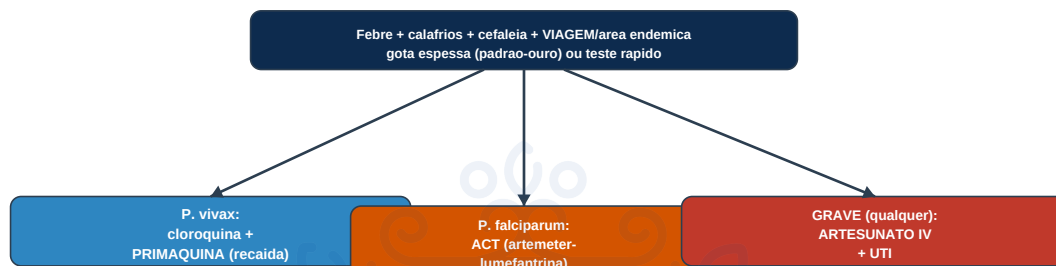


MALÁRIA — GOTA ESPESSA + ESPÉCIE GUIA

FLUXOGRAMA — SUSPEITAR, DIAGNOSTICAR, TRATAR

MALÁRIA — FEBRE + VIAGEM -> GOTA ESPESSA



DEFINIÇÃO E QUADRO CLÍNICO

SÍNDROME FEBRIL AGUDA

- Doença por protozoário Plasmodium, transmitida pelo mosquito Anopheles; fase hepática (assintomática) + fase sanguínea (sintomas, hemólise)
- Espécies mais relevantes: P. FALCIPARUM (grave) e P. VIVAX (recaídas por hipnozoítas); raras: transfusional, transplante, vertical
- Tríade clássica (> 80%): FEBRE + calafrios + cefaleia; febre intermitente/paroxística; mialgia, mal-estar, náuseas/vômitos, inapetência
- Grave (sobretudo falciparum): comprometimento neurológico (confusão/convulsões/coma), IRA, anemia intensa, icterícia, choque, sangramentos
- Ausência de rash, linfadenopatia e foco pulmonar ajuda a diferenciar de outras febris

ANAMNESE — A VIAGEM É A CHAVE

PERGUNTAS OBRIGATÓRIAS

- Viagem/residência em ÁREA ENDÊMICA (datas, locais, duração) — MUITO IMPORTANTE!
- Uso de profilaxia antimalárica (tipo, adesão, início/término)
- Padrão da febre (contínua/intermitente/paroxística), calafrios, sudorese; sintomas de gravidade
- Transfusão/transplante/agulhas compartilhadas; episódios prévios de malária (espécie, tratamento)
- Comorbidades/risco: imunossupressão, HIV, GRAVIDEZ, doenças hematológicas; contato com outros casos

EXAMES COMPLEMENTARES

GOTA ESPESSA É O PADRÃO-OURO

- MICROSCOPIA de esfregaço (gota espessa e fina, Giemsa): padrão-ouro — identifica o parasita, quantifica a parasitemia e distingue espécies (detecta 5-10 parasitas/uL)
- Testes rápidos (RDTs): úteis quando a microscopia não está disponível
- Sorologia NÃO tem papel no diagnóstico agudo
- Inespecíficos (apoio): hemograma (anemia hemolítica, trombocitopenia), bilirrubina indireta, LDH elevada, esquizócitos
- TESTAR G6PD obrigatoriamente antes de prescrever primaquina

TRATAMENTO POR ESPÉCIE E GRAVIDADE

Rx ESQUEMAS

P. FALCIPARUM (ou espécie desconhecida em área de risco): terapia combinada com artemisinina (ACT) — Artemeter-lumefantrina (mais usado); + Primaquina dose única (bloqueio de transmissão)

P. VIVAX (sensível à cloroquina): Etapa 1 — Cloroquina 3 dias (sangue); Etapa 2 — PRIMAQUINA 7-14 dias (hipnozoítas, previne recaída)

GRAVE (qualquer espécie): ARTESUNATO IV — 1ª linha (reduz mortalidade ~35% adultos, 22% crianças)

PRIMAQUINA contraindicada: deficiência de G6PD, gestantes, lactantes (bebê com G6PD desconhecido) — testar G6PD antes

Controle de cura: falciparum em D3/7/14/21/28/42; vivax/mista em D3/7/14/21/28/42/63

CRITÉRIOS DE MALÁRIA GRAVE / INTERNAÇÃO

QUALQUER UM = GRAVE

- Rebaixamento (Glasgow < 11), convulsões múltiplas (> 2/24h), prostração
- Insuficiência respiratória (SatO₂ < 92%, FR > 30, edema pulmonar), CHOQUE (PAS < 80 com hipoperfusão)
- Icterícia (BT > 3) com parasitemia > 100.000/uL; anemia grave (Hb <= 5 em < 12 anos; Hb < 7 em >= 12 anos) com parasitemia > 10.000
- IRA (creatinina > 3), acidose metabólica (lactato >= 5), hipoglicemia (< 40 mg/dL), sangramentos significativos
- Hiperparasitemia (falciparum > 10% dos eritrócitos); grupos de risco (crianças, gestantes, idosos, não imunes); incapacidade de tolerar VO -> internar

ALTA E ORIENTAÇÕES

QUANDO LIBERAR

- ☐ Tolerância à VO sem vômitos; ausência de critérios de gravidade (disfunções resolvidas)
- ☐ Afebril por 24-48h; parasitemia em declínio (idealmente < 1%); estabilidade hemodinâmica/respiratória
- ☐ Função renal estável/em melhora; Hb estável (sem necessidade de transfusão adicional)
- ☐ Capacidade de completar o tratamento oral em casa com seguimento garantido e exames de controle agendados
- ☐ Orientar: completar o tratamento até o fim (mesmo sem sintomas); não é contagiosa; retorno se febre alta, sonolência/confusão, dispneia, urina escura ou vômitos persistentes

MODELO DE REGULAÇÃO / TRANSFERÊNCIA

RESUMO PARA REGULAÇÃO

- Paciente ____ anos; suspeita de malária (esteve em área endêmica nos últimos 15-30 dias: ____); sintomas há ____ dias.
- Gota espessa/RDT: ____ (espécie / parasitemia); Hb ____, plaquetas ____, creatinina ____; Glasgow ____.
- Gravidade: ____ (neurológico/choque/IRA/icterícia/anemia grave/hiperparasitemia); tratamento iniciado: ____ (artesanato IV / ACT / cloroquina) às ____.
- Solicito UTI / manejo de complicações (IRA/SARA/anemia grave) / ajuste especializado; testar G6PD antes da primaquina.



SM24
Suporte ao Plantão Médico

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

USP-SP / Adaptada

Qual é o exame padrão-ouro para o diagnóstico de malária?

- A) Sorologia IgM
- B) Microscopia de gota espessa (esfregaço corado por Giemsa)
- C) Hemocultura
- D) PCR de urina
- E) Prova do laço

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

No tratamento da malária por *P. vivax*, qual fármaco previne as recaídas ao eliminar os hipnozoítas hepáticos?

- A) Cloroquina
- B) Primaquina
- C) Artesunato
- D) Doxiciclina
- E) Azitromicina

QUESTÃO 3

SES-DF / Adaptada

Qual é o tratamento de primeira linha da malária GRAVE (qualquer espécie)?

- A) Cloroquina oral
- B) Artesunato intravenoso
- C) Primaquina isolada
- D) Doxiciclina oral
- E) Apenas hidratação

QUESTÃO 4

UNIFESP / Adaptada

O que deve ser obrigatoriamente testado antes de prescrever primaquina?

- A) Função tireoidiana
- B) Deficiência de G6PD
- C) Sorologia para HIV
- D) Glicemia de jejum
- E) Coagulograma

QUESTÃO 5

UFRJ / Adaptada

Qual dado da anamnese é fundamental e não pode faltar na suspeita de malária?

- A) História de tabagismo
- B) Viagem ou residência em área endêmica
- C) Vacinação infantil
- D) História cirúrgica
- E) Uso de anticoncepcional

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

A microscopia de gota espessa (esfregaço corado por Giemsa) é o padrão-ouro: identifica o parasita, quantifica a parasitemia e distingue as espécies. A sorologia não serve para o diagnóstico agudo.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

A primaquina elimina os hipnozoítas hepáticos do *P. vivax*, prevenindo recaídas; a cloroquina trata a fase sanguínea. Testar G6PD antes da primaquina.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

Na malária grave (qualquer espécie), o artesunato intravenoso é a 1ª linha, reduzindo a mortalidade em relação aos demais esquemas.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

A deficiência de G6PD deve ser testada antes da primaquina (risco de hemólise); a primaquina também é contraindicada em gestantes e lactantes com bebê de G6PD desconhecido.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

A história de viagem ou residência em área endêmica é o dado epidemiológico fundamental para suspeitar de malária diante de uma síndrome febril aguda.

SM24
Suporte ao Plantão Médico